Клинические рекомендации

Одонтогенный остеомиелит челюсти

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K10.2** — Воспалительные заболевания челюстей
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 19.06.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/1049_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определения 2

2.2 Этиология и эпидемиология 2

2.3 Классификация 2

2.4 Клиническая картина 3

3. Диагностика 3

3.1 Жалобы и анамнез 3

3.2 Консультации специалистов 3

3.3 Физикальное обследование 4

3.4 Лучевые и лабораторные исследования 4

4. Лечение 4

4.1 Условия лечения 4

4.2 Хирургическое лечение 5

4.3 Медикаментозное лечение 5

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 6

5.1 Профилактика 6

5.2 Показания к госпитализации 6

6. Источник и актуальность 6

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 6

1. Основные положения

- Остеомиелит челюсти — гнойно-некротическое воспаление всех структур челюстной кости одонтогенного или неодонтогенного происхождения; острый одонтогенный остеомиелит выходит за пределы одного зубо-альвеолярного сегмента.
- Для оториноларинголога: при остеомиелите верхней челюсти с «причинным» премоляром или моляром возможен верхнечелюстной синусит (чаще острый серозный, на фоне хронического — обострение гнойного); показаны консультация оториноларинголога и КТ околоносовых пазух.
- Лечение остеомиелита — в стационаре в неотложном порядке: удаление «причинного» зуба, вскрытие и дренирование очага, антибактериальная терапия; при подострой и хронической стадии — секвестрэктомия, при поражении стенок пазухи — по типу операции Колдуэлла — Люка.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Остеомиелит челюсти — гнойно-некротическое воспалительное заболевание костной ткани челюстной кости (одновременно всех её структурных компонентов) инфекционно-аллергической природы одонтогенного или неодонтогенного происхождения.

Острый одонтогенный остеомиелит — процесс, при котором зона поражения распространяется за пределы входного зубо-альвеолярного сегмента — на пародонт соседних зубов или тело челюсти.

Периостит, в отличие от него, ограничен пределами одного зубо-альвеолярного сегмента.

Верхней границей зубо-альвеолярных сегментов верхней челюсти является дно полости носа и верхнечелюстных синусов.

2.2 Этиология и эпидемиология

Периостит развивается на фоне острого или обострения хронических одонтогенных заболеваний, чаще всего хронического периодонтита, реже пародонтита, перикоронита. Возбудители — условно-патогенная микробиота полости рта: факультативные и строгие анаэробы.

Одонтогенный остеомиелит составляет до 74,2% всех остеомиелитов челюстей; встречается преимущественно у мужчин среднего возраста. У госпитализированных пациентов поражение нижней челюсти — в 85% случаев.

2.3 Классификация

1. **периостит челюсти** — острый (серозный, гнойный — ограниченный, диффузный) и хронический (простой, оссифицирующий, рарефицирующий)
2. **остеомиелит по этиологии** — одонтогенный, гематогенный, травматический (в том числе огнестрельный), контактный
3. **по В. И. Лукьяненко (1968)** — форма — острая, подострая, хроническая, обострение хронической; тяжесть — лёгкая, средняя, тяжёлая; локализация — верхняя, нижняя челюсть; распространённость — ограниченный, распространённый, диффузный

2.4 Клиническая картина

При распространении воспаления в костных структурах верхней челюсти вверх, в верхнечелюстную пазуху, возможно развитие верхнечелюстного синусита.

1. **как правило** — острый серозный синусит
2. **«причинный» премоляр или моляр на фоне хронического одонтогенного или смешанного синусита** — обострение хронического гнойного синусита
3. **тактика** — консультация оториноларинголога и контрольное рентгенологическое исследование околоносовых пазух, при технической возможности — КТ

При локализации процесса в зоне моляров верхней челюсти возможен пристеночный отёк слизистой оболочки альвеолярной бухты в области дна верхнечелюстной пазухи над «причинным» зубом — его расценивают как «муфтообразный» инфильтрат.

---

3. Диагностика

3.1 Жалобы и анамнез

При дифференциальной диагностике учитывают жалобы

1. локализация и характер боли — в области одного «причинного» зуба, нескольких зубов и/или челюсти;
2. иррадиация по ходу ветвей тройничного нерва;
3. подвижность одного, двух или нескольких соседних зубов;
4. отёк слизистой оболочки и околочелюстных мягких тканей;
5. парестезии губы, зубов, кожи анатомической области;
6. ограничение открывания рта.

3.2 Консультации специалистов

Всем пациентам показана консультация челюстно-лицевого хирурга и/или стоматолога-хирурга.

Консультация терапевта — при сопутствующей патологии.

Консультация офтальмолога — при тотальном или субтотальном гнойно-некротическом процессе верхней челюсти с распространением на глазницу.

Консультация невролога — при неврологических нарушениях.

Консультация анестезиолога-реаниматолога — перед операцией под сочетанной анестезией или наркозом и при тяжёлой сопутствующей патологии.

При локализации гнойного процесса в верхней челюсти и признаках верхнечелюстного синусита показана консультация оториноларинголога.

Задачи оториноларинголога

1. оценка состояния ЛОР-органов и уточнение диагноза;
2. определение показаний к пункции верхнечелюстной пазухи;
3. коррекция комплексного, в том числе местного, лечения;
4. согласование со стоматологом протокола лечения для предупреждения осложнений со стороны ЛОР-органов.

3.3 Физикальное обследование

Проводится общеклинический осмотр: кожа, слизистые оболочки, ЧСС, артериальное давление, частота дыхания.

Внешний осмотр.

Пальпация и осмотр органов полости рта.

Определение степени открывания рта.

Перкуссия и определение патологической подвижности зубов на поражённом участке челюсти.

Оценка чувствительности нижней губы и подбородка или верхней губы и подглазничной области на стороне поражения.

3.4 Лучевые и лабораторные исследования

Всем пациентам выполняется рентгенологическое исследование челюстно-лицевой зоны для уточнения «причинного» зуба и характера поражения кости: внутриротовая контактная, окклюзионная рентгенография, обзорная рентгенограмма челюсти, рентгенография черепа.

При остром диффузном периостите, субтотальном или тотальном остром, хроническом и обострении хронического остеомиелита, при технической возможности, выполняется КТ челюстно-лицевой области (КЛКТ или МСКТ челюстей).

При предполагаемом остром субтотальном или тотальном остеомиелите показано УЗИ тканей полости рта.

Перед экстренной операцией выполняется комплекс лабораторных исследований.

У всех пациентов в стационаре проводится микробиологическое исследование отделяемого из лунки «причинного» зуба и свищевых ходов с определением чувствительности к антимикробным препаратам.

Цитологическое и патолого-анатомическое исследование проводится для дифференциальной диагностики со специфическими заболеваниями (актиномикоз, туберкулёз, сифилис), опухолями (саркома Юинга) и опухолеподобными образованиями челюстей.

---

4. Лечение

4.1 Условия лечения

Лечение периостита возможно в стоматологической поликлинике в режиме неотложной помощи — только при отсутствии сопутствующей патологии, нормергическом течении и без рисков осложнений.

Одонтогенный остеомиелит лечится в стационаре в режиме неотложной помощи.

При декомпенсированной сопутствующей патологии или гиперергическом течении — многопрофильный стационар.

4.2 Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство выполняется с учётом патогенеза и фазы гнойно-воспалительного процесса.

Удаление «причинного» зуба — для оттока экссудата из первичного очага.

Обязательное вскрытие и дренирование абсцесса полости рта.

При остром периостите — вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса.

При остром и обострении хронического остеомиелита — вскрытие очага в полости рта с обеих сторон челюсти; при флегмоне или свище — внеротовой или сочетанный доступ.

При подострой стадии и хроническом остеомиелите — секвестрэктомия под сочетанной анестезией или комбинированным эндотрахеальным наркозом.

На верхней челюсти рационально использовать внутриротовые доступы. При осложнении остеомиелита верхней челюсти верхнечелюстным синуситом или секвестрации стенок верхнечелюстной пазухи секвестрэктомию целесообразно выполнять по типу радикальной синусотомии (операция по Колдуэллу — Люку).

При остром серозном периостите, если «причинный» зуб — резец или клык, решается вопрос о его сохранении.

При декомпенсированной сопутствующей патологии и приёме антикоагулянтов удаление зуба отсрочено.

При технических трудностях удаления — отсроченное удаление при обязательном дренировании очага: периостеотомия и «остеоперфорация» в проекции зуба.

4.3 Медикаментозное лечение

Рациональная антибактериальная терапия входит в комплексное лечение.

При назначении соблюдаются рекомендации «СКАТ».

Эмпирическую терапию начинают после дренирования очага, обязательно направляя материал на микробиологическое исследование.

После результатов посева переходят на целенаправленную терапию; длительность определяется динамикой процесса, состоянием и анализами.

При отсутствии динамики схему корректируют, проводят ревизию очага и исключают распространение на соседние клетчаточные пространства.

С дезинтоксикационной целью применяют кровезаменители и перфузионные растворы.

Контроль нутритивного статуса и нутритивная поддержка при хирургическом лечении.

Антикоагулянты — при диффузном остеомиелите верхней челюсти, осложнённом течении, декомпенсированной патологии, с профилактикой ВТЭО.

Антигистаминные средства — для снижения гиперергического фона.

НПВП и анальгетики — для купирования боли.

Гипербарическая оксигенация — при технической возможности; озонотерапия — при вялотекущем и хроническом течении.

Местное лечение раны — по фазам раневого процесса: противомикробные препараты и антисептики, при некрозе — протеолитические ферменты, затем средства, оптимизирующие регенерацию.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Рекомендуется своевременная санация полости рта: выявление и лечение кариеса и его осложнений, воспалительных заболеваний пародонта.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация

1. острый серозный или гнойный периостит при суб- или декомпенсированной сопутствующей патологии;
2. гиперергическое течение воспаления;
3. злокачественные новообразования любой локализации;
4. иммунодефицитные состояния.

Плановая госпитализация

1. подострая фаза и хронический остеомиелит при сформированном секвестре;
2. затяжное, торпидное или прогрессирующее течение хронического остеомиелита с длительным формированием секвестров.

Критерии выписки

1. неосложнённое течение раннего послеоперационного периода, удовлетворительное состояние, боль купируется пероральными средствами, антибиотики можно принимать амбулаторно;
2. перевод в другое учреждение;
3. требование пациента или его законного представителя;
4. несоблюдение предписаний, если это не угрожает жизни.

Помощь оказывается в многопрофильном стационаре с возможностью консультаций терапевта и узких специалистов (невролога, оториноларинголога, офтальмолога): при «причинных» премолярах и молярах возможно развитие одонтогенного верхнечелюстного синусита.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Воспалительные заболевания челюстей. Одонтогенный остеомиелит челюсти»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 19.06.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2029 года
Код в рубрикаторе	1049_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.